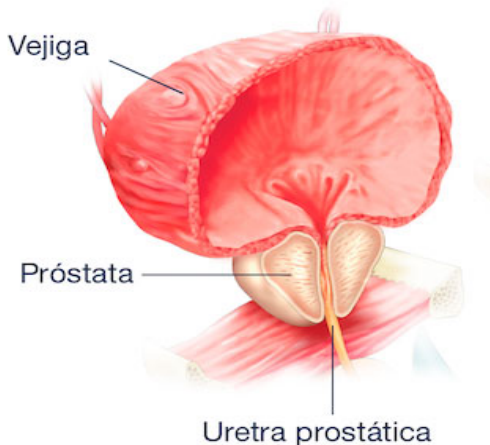




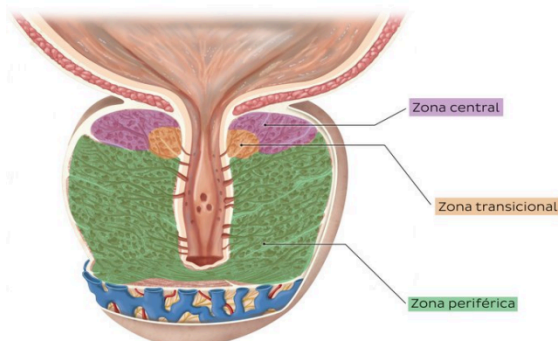
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 Semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRACTICA.
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR: PROSTATECTOMÍA SUPRAPÚBICA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo quirúrgico (Hacer descripción) Acceder al adenoma prostático mediante una incisión directa en la cápsula prostática anterior sin entrar en la vejiga, minimizando el trauma vesical.			
1.2. Anatomía y fisiología (Hacer gráfico y descripción) ANATOMIA  Es una glándula accesoria del sistema reproductor masculino. Es del tamaño de una nuez, y se localiza			



alrededor de la porción prostática de la uretra (uretra prostática). Anatómicamente, la próstata está compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.

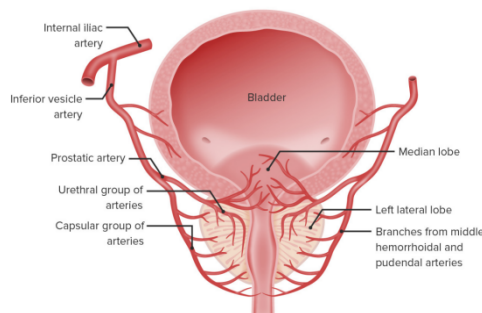
1. **ISTMO:** Se encuentra anterior a la uretra. Está compuesto principalmente por tejido fibroso y muscular, con poco o nulo tejido glandular.
2. **LOBULO IZQUIERDO Y DERECHO:** Están separados anteriormente por el istmo, y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende sobre la línea media de la cara posterior de la próstata. Cada lóbulo está dividido en cuatro lobulillos, con base en sus relaciones anatómicas con el conducto eyaculador y la uretra prostática, que son los siguientes:
 - Lobulillo inferoposterior: inferior a la uretra y posterior al conducto eyaculador.
 - Lobulillo inferolateral: posicionado lateralmente a la uretra.
 - Lobulillo superomedial: por debajo del lobulillo inferoposterior y alrededor del conducto eyaculador.
 - Lobulillo anteromedial: inferior al lobulillo inferolateral y lateral a la porción proximal de la uretra prostática.

La próstata consta a su vez de una base, vertice, cara anterior, cara posterior y unas caras inferolaterales. Y a su vez se divide en zonas: una zona central, una zona periférica, zona transicional y estroma fibromuscular anterior



1. **Zona central:** se encuentra en la base de la próstata, envolviendo los conductos eyaculadores y se conforma por las glándulas submucosas periuretrales
2. **Zona transicional:** es corta y rodea la porción proximal de la uretra prostática superior al colículo seminal, está formada por las glándulas mucosas periuretrales.
3. **Zona periférica:** Se compone por las glándulas prostáticas principales

VASCULARIZACION



La fuente principal de irrigación arterial de la próstata es:

- Arteria pudenda interna, con algunas contribuciones adicionales de las arterias vesical inferior y rectal media

INERVACION

Esta inervada por las fibras parasimpáticas de los nervios espláncnicos pélvicos del plexo prostático, que reciben sus fibras del plexo hipogástrico inferior (para erección y efecto secretomotor de acinos), el plexo hipogástrico inferior a su vez recibe fibras simpáticas preganglionares del plexo hipogástrico superior para brindar inervación motora a los músculos lisos del estroma glandular (para eyaculación y contracción muscular lisa).

FISIOLOGIA

Su función es la de producir el fluido prostático, que, en combinación con el espermatozoides proveniente de los testículos, componen el semen y a su vez la función principal del fluido prostático es activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción.



1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general	Paquete de ropa Pala larga del electrobisturí Cánula de Yankauer Guantes Torundas Disectores Gasas Apósito HBF #20, II y 15 Electrobisturí Consola del electro Caucho de succión Mango de bisturí 3 y 4 Cystoflo Frasco de patología Dren de Penrose ancho jeringa de 20 y 60 cc punta catéter	Piel: Nylon 2/0 SC26 o 3/0 SC24 TCS y músculo: C/C 0 o 2/0 CTI Fascia: Vicryl 1 CTI Vejiga: C/C 0 2/0 CTI Lecho prostático: C/C 1 CTI Fijar sonda: Seda 2/0 SC26	Suero fisiológico o agua estéril Xilocaína Jalea



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

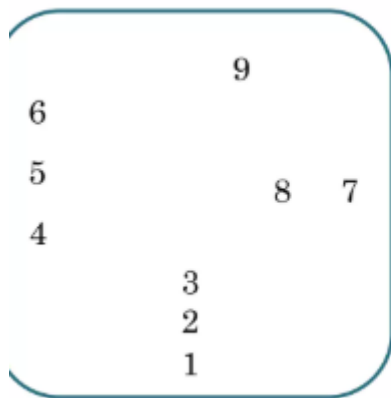
PLANEAMIENTO QUIRÚRGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

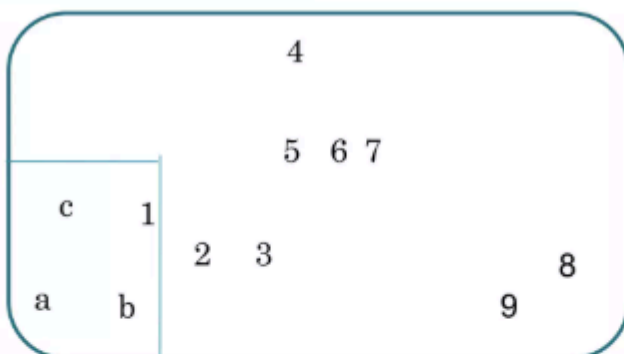
	Sondas de Foley #22 y #24 de 2 y 3 vías, mecha prostática cistoflo, sondas Nelaton 6, Uromatic, equipo macrogoteo		
--	---	--	--

1. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



1. MB #4 o #7, HB #20 o #11-15 (respectivamente)
2. Tijeras de Metzenbaum
3. Tijeras de Mayo
4. Pinzas Kelly
5. Pinzas Rochester
6. Pinzas Kelly adson
7. Pinzas de Disección con y sin garra
8. Separadores de Farabeut
9. Pinzas Allis.

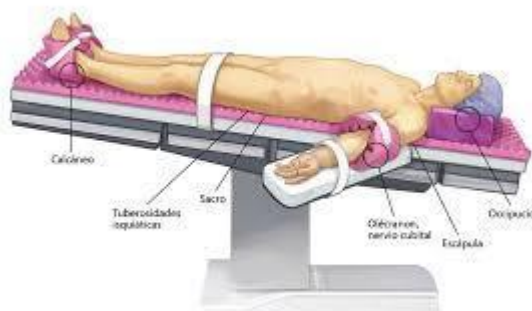


1. Bandeja con instrumental sobrante:
 - a. Gasas
 - b. Cocas con agua.
 - c. Compresas
2. Separadores ; Abdominal o vesical, deaver
3. Pinzas Babcock
4. Compresa doblada
5. P. Císticas
6. P. de disección con y sin garras largas
7. P. Foester
8. Paquete de ropa
9. Pinzas de campo Backaus



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Posición de trendelemburg moderada



2.3 Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico)



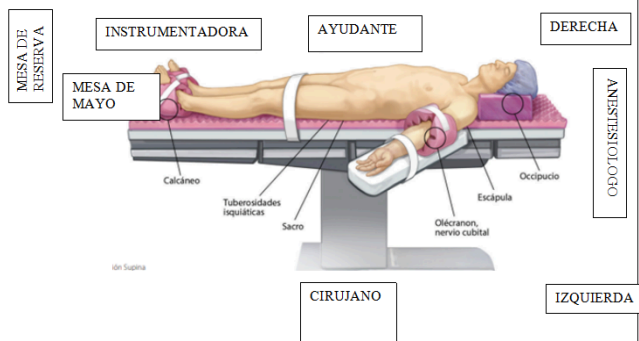
**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

PLANEAMIENTO QUIRÚRGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



1.

2. **ETAPA DE EJECUCION:**

a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia): Raquídea

b) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

Incisión Pfannestiel



c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Se realiza incisión Pfannestiel en la piel, tejido celular subcutáneo	Mango de bisturí 4 con hoja 20
Se realiza hemostasia	Pinza Kelly curva y lapicero del electrobisturi
Se visualiza la fascia	Separadores de farabeuf
Se realiza la divulsión de los músculos y se visualiza la cavidad extraperitoneal	Pinza Kelly curva y separadores deaver anchos
Se rechaza la vejiga	Valva maleable
Se diseccionan los vasos superficiales y los ligamentos pubo prostáticos, se clampean y se ligan	Pinza cístico, Kelly adson y poliglactina 910 calibre 0 ½

Se incide una y luego se hace la disección de la fascia endopelvica	Tijeras de metzenbaum
Se clampea la vena dorsal del pene a través de la fascia Endo pélvica	Pinza cístico-larga
Se realiza ligadura	Seda 0 sin aguja
Haciendo sección de la vena dorsal del pene y los ligamentos pubo prostáticos se identifica la uretra	Mango bisturí 3 con hoja 15, tijeras de metzenbaum, disección vascular, pinza cístico y pinza Kelly adson
Se realiza disección de la próstata hacia abajo y se visualiza la unión prostática uretral	Pinza Rochester recta, Torundas
Se realiza sección de la uretra con la sonda se repara, se tracciona la capsula y se lleva hacia atrás	Tijeras finas, sonda foley , pinza cístico
Se realiza liberación de las adherencias de los músculos elevadores del ano y rectales	Pinza foerster, pinza pennington
Se reparan los musculos elevadores del ano	Pinza Kelly curva y poliglactina 910 ACR ½ circulo
Se realiza liberación de la próstata y se corta a nivel del cuello y vejiga	Tijeras de metzenbaum, mango de bisturí 3 largo con hoja de bisturí 15
Se realiza la disección roma en la pared prostática y vejiga para poder encontrar las vesículas seminales	Pinzas Rochester
Se realiza la sección de los conductos deferentes	Tijeras de metzenbaum y torunda
Se realiza la ligadura de los pedículos seminales	Pinza Kelly adson, pinza cistico, sutura natural no absorbible trenzada 2/0
Se realiza la plastia del cuello vesical	Portaagujas largo, pinza de disección larga, catgut cromado 3/0 aguja ½ circulo redonda
Se realiza anastomosis del cuello vesical de la uretra	Portaagujas largo, pinza de disección larga, catgut cromado 2/0 aguja curva ½ circulo redonda
Se coloca una segunda sonda Foley 22X30 y se anudan los reparos anteriores	Jeringa 20 cc, equipo de venoclisis y solución salina
Se deja un dren por contraabertura	Pinzas Rochester
Se realiza hemostasia y recuento	Pinza foerster
Se cierra por planos	Portaagujas mediano, pinza de disección con garra, separadores de Farabeuf, disección adson con garra,



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

PLANEAMIENTO QUIRÚRGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

sutura sintética absorbible calibre 1 agua ½ circulo
redonda, polipropileno 3/0 aguja curva de 3/8 de
circulo cortante

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____